

TRIAGEM & FILA INTELIGENTE

Pronto-Socorro · Hospital Geral Vila Penteado

Um PS que decide com dado.

Da porta ao desfecho — em uma plataforma única.

Apresentação · Proponente: Pedro Wlassak

08/06/2026



O PROBLEMA

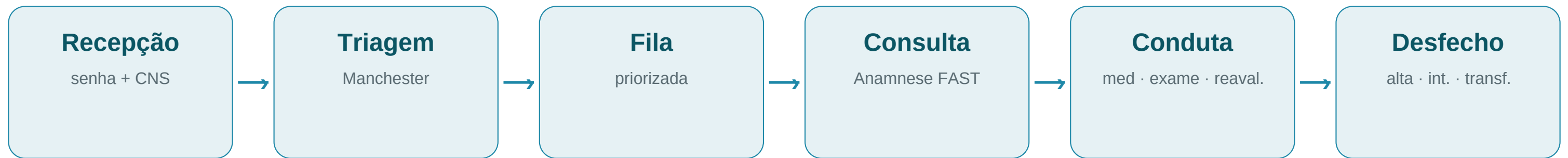
Hoje o PS decide no escuro.

- Fichas com classificação Manchester — sem rastreabilidade de tempo de espera.
- Triagem em papel — dado clínico não é estruturado nem auditável.
- Reavaliação informal — depende da memória da equipe.
- Evasão silenciosa — quem vai embora ninguém conta.
- Sem visibilidade em tempo real do gargalo.

Uma plataforma única da porta ao desfecho.

Gera dado estruturado em cada etapa, prioriza por gravidade, e usa o dado para prever lotação e mudar desfecho.

O paciente em um único fluxo digital.



Cada transição gera um evento com timestamp, responsável e contexto clínico.

Cada cor é um SLA clínico.

Vermelho

Emergência

0 min

Laranja

Muito urgente

10 min

Amarelo

Urgente

60 min

Verde

Pouco urgente

120 min

Não é por chegada — é por risco.

A fila combina cor Manchester + tempo de espera + disponibilidade.

PRIORIDADE

Quem corre risco vai antes — sempre.

ALERTA

Tempo-alvo estourado fica em destaque vermelho.

RE-TRIAGEM

Enfermagem pode promover paciente se piorar.

CHAMADOR

Painel grande + voz. TV na sala de espera.

CHAMANDO AGORA

A0042

Antônio Pereira

Consultório 2

ÚLTIMAS CHAMADAS

A0041 Maria Santos

A0040 João Oliveira

A0039 Lucas Pinto

Destino × Tarefas.

O médico escolhe destino e marca tarefas. O sistema só fecha quando tudo conclui.

DESTINO (escolhe 1)

- Alta hospitalar
- Reavaliação
- Internação / Observação
- Transferência

TAREFAS (qualquer combinação)

- Medicação (com timer)
- Exame de imagem
- Exame laboratorial

Internação e transferência têm fluxo próprio.

Nada cai no esquecimento.

Toda reavaliação tem critério, prazo e responsável.

Pós-medicação

timer fixo após administração

Observação clínica

janela de 2 a 6 horas

Aguardando exame

até resultado chegar

Piora detectada

re-triagem da enfermagem sobe na fila

KPIs ao vivo.



Distribuição Manchester, gargalos, evasão por turno e tempos atualizados em tempo real.

Cada plantão gera 4 arquivos.

Auditoria, qualidade e BI prontos para download — todos os dias.

.md

Dados brutos

Markdown com tabela + detalhe clínico por paciente.

.txt

Dados brutos

Texto plano alinhado, pronto para auditoria.

.txt

Relatório métrico

Desfechos, Manchester, medianas, p90.

.pdf

Relatório PDF

Mesmo relatório com gráficos e KPIs.

Compatível com o ecossistema nacional.

HL7 FHIR R4

Modelagem clínica padrão internacional.

RNDS-ready

Pronto para Rede Nacional de Dados em Saúde.

Power BI

Conexão direta com Postgres — dashboards do hospital.

On-premise

Dado clínico fica no hospital — LGPD respeitada.

Antecipa a lotação.

Antecipa a piora.

Após 15-30 dias de dado, dois modelos entram em operação:

Predição de fluxo

Quantos pacientes nas próximas horas → escalar equipe antes.

Predição de desfecho

Risco individual de internação ou piora → repriorizar a fila.

Ganha o paciente, a equipe e a gestão.

Paciente

- Atendido por gravidade
- Espera transparente
- Piora detectada na espera

Equipe

- Fim do papel solto
- Fila justa e clara
- Reavaliação sem esquecer

Gestão

- KPIs em tempo real
- Identifica gargalo
- Decide com dado, não com intuição

PROVA DE CONCEITO

90 dias no PS do HGVP.

SEMANA 1-2

Setup + treinamento da equipe

SEMANA 3-4

Piloto controlado em horário diurno

SEMANA 5-12

Operação 24/7 + indicadores semanais

SEMANA 13

Apresentação de resultados à gestão

Métricas medidas: porta-triagem, porta-médico, taxa de evasão, permanência, satisfação.

O QUE PEDIMOS

Autorização para a PoC.

90 dias no PS, dado on-premise, equipe treinada,
relatório executivo ao fim do período.

Continuidade — ou encerramento sem custo — com base em métricas.

OBRIGADO

Vamos conversar?

Pedro Wlassak · Proponente técnico e clínico

Hospital Geral Vila Penteado · Pronto-Socorro

